EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 73692
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-11-07 10:48:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CLEOME BUSTOS SAAVEDRA			RUN	: 2.546.882-1
F.Nac	: 01-11-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-11-03	Fecha Egreso	: 2023-11-07 10:48:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E87.0-HIPEROSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Infección respiratoria alta
2. Encefalopatía metabólica
3. Hipernatremia severa con VEC disminuido resuelta
4. Deshidratación severa resuelta
5. Falla renal aguda resuelta
6. Postrada - Dependencia Severa para ABVD

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. E87.0-HIPEROSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 97 años con dependencia severa ABVD, postrada. Es traído por familiar por presentar compromiso del estado general, hipoalimentacion y somnolencia. Al ingreso en malas condiciones generales, deshidratación severa, taquicardica, con agregados respiratorios y heridas erosivas en ambas piernas con piel seca eritema y costras, GCS 13pts, en exámenes destaca Creat 1.9 PCR: 276,2 Na: 179 Leucocitos: 18,400 por lo que se hospitaliza para manejo.
Se inicia manejo de hipernatremia y ABT de primera línea con buena respuesta, se mantiene HDM estable, normocardica, mejor hidratación, sin conflicto respiratorio, sin requerimientos de O2, se mantiene vigil, pero sin conexión al medio, por lo que se decide mantener SNG para alimentación a permanencia por riesgo de Broncoaspiración.
Hoy vigil espontaneo pero sin conexión al medio, HDM Estable, normocardica, Eupneica, sin req de O2, MP con roncus finos bilaterales. Abdomen sin signos de alarma. Edema de EESS
Lab control Creat 1.2 (previa 1.9) PCR 172 (previa 276) Na 144 (180). Se decide ajustar ABT a ampicilina sulbactam y egreso con HODOM para completar abt, kine resp y educación de cuidados de SNG.

INDICACIONES AL ALTA

1. Alta con HODOM
2. Cuidados en domicilio
3. Reposo relativo, movilizar en cama cada 4 hrs
4. Prevención de UPP - Contención física
5. Régimen por SNG líquidos según pauta nutricional mas agua
6. Ampicilina/ sulbactam 1.5 gr vev cada 12 hrs por 5 días
7. Gluconato de potasio 15ml por SNG cada 8 hrs por 5 días
8. Paracetamol 500mg cada 8 hrs por SNG sos dolor o fiebre
9. kien resp/motora

10. Entrenamiento a familiar de cuidados de SNG y alimentación (pauta nutricional)
11. Control por programa postrados de su APS

Neidy Osmary Quijada de Prado
MEDICO TRATANTE
26127834-0

JEFE SERVICIO